

胆囊术后 / 未术后 人群饮食指南（免费版）

askdrliu.com | 品牌宣言：从保胆取石到术后管理，守护患者长期生活质量

适合患者转发：短期、中期、长期重点，一次看懂。

先看4条结论

- 术后可低脂过渡，但不建议长期极低脂。
- 长期重点：体重、腰围、血糖血脂、脂肪肝管理。
- 餐后急便/水样便持续，要警惕胆汁酸相关腹泻。
- 脂溶性维生素A/D/E/K：先评估，再补充。

术后分阶段饮食（时间轴）



目标：稳住肠胃

- ☐ 少量多餐，每日4-6餐
- ☐ 先避油炸、肥肉、奶油
- ☐ 蛋白质优先（鱼蛋豆瘦肉）
- ☐ 暂不饮酒

目标：恢复结构

- ☐ 每餐：蛋白+蔬菜+全谷
- ☐ 选好油：橄榄/菜籽/坚果
- ☐ 避免“怕油改吃高糖”
- ☐ 每周 $\geq$ 150分钟活动

目标：长期代谢稳定

- ☐ 管体重和腰围
- ☐ 规律作息、避免久坐
- ☐ 不极端节食
- ☐ 每年一次代谢复查

未切除胆囊人群：同样适用

- ☐ 目标是减少发作和进展风险，不是“终身零脂肪”。
- ☐ 避免快速减重和体重反弹；多纤维，少精制糖。
- ☐ 保留食物-症状日记，找出你的个人触发食物。

立刻就医信号

- ☐ 持续腹痛、发热、黄疸（皮肤或眼白发黄）
- ☐ 黑便、便血、反复呕吐、明显脱水
- ☐ 短期体重明显下降，或夜间腹泻影响睡眠

本手册用于健康教育，不替代门诊评估。

三个长期关键：维生素、脂肪肝、代谢

askdrliu.com | 品牌宣言：从保胆取石到术后管理，守护患者长期生活质量

A/D/E/K

脂溶性维生素：什么时候要特别留意？

高风险人群：

- ☐ 持续水样便、油便、体重下降
- ☐ 长期使用考来烯胺等胆汁酸结合剂
- ☐ 骨质疏松高风险（绝经后、老年、少晒太阳）

实用原则：

- ☐ 不盲目长期大剂量补充
- ☐ 先评估风险，再按医生建议检测/补充

脂肪肝风险

术后长期要防的不是“吃油”，而是代偿性高糖

常见误区：怕油 -> 主食和甜食明显增多 -> 甘油三酯和肝脂上升

正确做法：优先“油脂质量”而非“油脂归零”

- ☐ 用植物油、坚果、鱼类脂肪替代高饱和脂肪
- ☐ 保证蛋白质摄入，减少夜宵和含糖饮料
- ☐ 超重者循序减重（通常先减5%–10%体重）

代谢管理

每年至少一次“胆囊+代谢”联合复查

建议检查：体重、腰围、血糖/糖化、血脂、肝功能

已有糖尿病/高脂血症/脂肪肝者：按医生建议提前复查

一句话：决定长期结局的，往往是代谢控制，不是“是否完全忌油”。

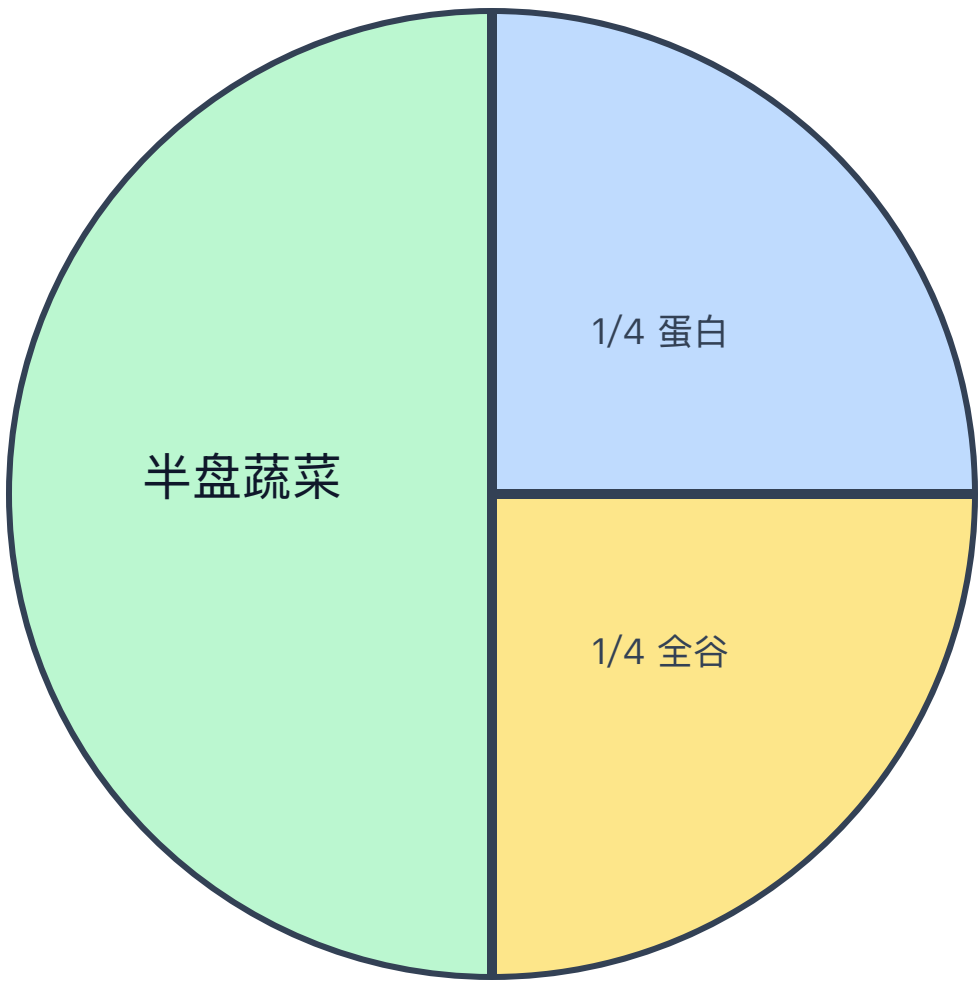
患者最常见痛点 + 每日餐盘模板

askdrliu.com | 品牌宣言：从保胆取石到术后管理，守护患者长期生活质量

四个常被忽视的痛点

- 1) 长期极低脂：
饱腹差、营养不均、后续更容易反弹
- 2) 不吃油改高糖：
甘油三酯升高、脂肪肝风险更高
- 3) 术后慢性腹泻：
可能是胆汁酸相关腹泻，不只是“肠炎”
- 4) 长期用药不评估营养：
胆汁酸结合剂可影响A/D/E/K吸收

每天可执行餐盘法



☐ 少量健康脂肪：坚果或1-2茶匙植物油

7天可落地执行清单

- ☐ 每天：三餐定时 + 1次轻活动（饭后散步20-30分钟）
- ☐ 每天：饮水够量，尽量不喝含糖饮料和酒
- ☐ 每周：准备2-3种优质蛋白（鱼、蛋、豆腐、鸡胸）
- ☐ 每周：至少5天吃到足量蔬菜（深色叶菜+菌菇+瓜茄）
- ☐ 每周：记录2-3次“食物-症状”观察（腹胀、腹泻、油便）
- ☐ 每月：称体重、测腰围，确认是否在稳定改善

一句话给患者

“你不需要终身吃得很清苦，而是要长期吃得稳定、规律、可坚持。”

“真正影响远期结局的是代谢管理：体重、腰围、血糖血脂和肝脏脂肪。”

参考文献与来源（可追溯）

askdrliu.com | 品牌宣言：从保胆取石到术后管理，守护患者长期生活质量

以下为患者教育版的核心依据，建议医护保留原文核验。

1. BMJ Open (2022) Post-cholecystectomy diarrhoea systematic review

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35177439/

2. World J Gastrointest Surg (2023) Diagnosis and treatment review

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10725554/

3. Int J Surg (2023) Cholecystectomy and risk of liver disease

https://journals.lww.com/international-journal-of-surgery/fulltext/2023/05000/cholecystectomy_and_risk_of_liver_disease__a.37.aspx

4. Annals of Surgery (2023) Increased risk of type 2 diabetes

https://journals.lww.com/annalsofsurgery/fulltext/2023/08000/cholecystectomy_increases_the_risk_of_type_2.32.aspx

5. Hepatobiliary Surg Nutr (2023) Risk of metabolic syndrome

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37600984/

6. NIDDK/NIH: Gallstones diet & nutrition

https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/gallstones/eating-diet-nutrition

7. NIDDK/NIH: Dieting and gallstones

https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/gallstones/dieting

8. AGA guideline/statement on chronic diarrhea evaluation

https://gastro.org/press-releases/aga-releases-guideline-on-the-evaluation-of-chronic-diarrhea-1/

9. DailyMed: Cholestyramine label (fat-soluble vitamin caution)

https://dailymed-beta.nlm.nih.gov/dailymed/fda/fdaDrugXsl.cfm?setid=2835b6f5-93da-4554-9d84-79132fd928ee&type=display

使用声明

- ☐ 本PDF为患者教育材料，不替代个体化诊疗方案。
- ☐ 不同病人病史和用药不同，最终以门诊医生建议为准。
- ☐ 可免费转发，但不建议删改原始参考来源。

个人品牌宣言

askdrliu.com | 品牌宣言：从保胆取石到术后管理，守护患者长期生活质量